

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING PENYAKIT JANTUNG BAWAAN (PJB) KRITIS		
	No.Dokumen 431.1/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Skrining PJB Kritis adalah pemeriksaan saturasi oksigen pada bayi baru lahir menggunakan alat pulse oximetry untuk mendeteksi adanya kelainan struktur jantung yang berat sebelum bayi menunjukkan gejala klinis atau diperbolehkan pulang		
Tujuan	1. Mendeteksi dini PJB kritis (seperti <i>Hypoplastic Left Heart Syndrome, Tetralogy of Fallot</i> , dll) 2. Menurunkan angka kematian dan morbiditas bayi baru lahir akibat keterlambatan penanganan jantung 3. Memastikan bayi mendapatkan rujukan ke spesialis jantung anak jika hasil skrining positif		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan PONEK 24 jam 2. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/1511/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skrining Bayi Baru Lahir, yang memperbarui aspek teknis dan integrasi layanan		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Pulse Oximeter (disarankan tipe yang memiliki akurasi tinggi pada perfusi rendah) 2. Probe sensor (ukuran neonatus) 3. Kapas alkohol/tisu pembersih 4. Lembar kerja/Grafik Algoritma Skrining PJB Kritis B. Persiapan Pasien 1. Bayi dalam kondisi tenang, tidak menangis, dan tidak sedang tidur lelap (jika memungkinkan) 2. Bayi telah berusia minimal 24 jam setelah lahir, atau sebelum bayi pulang jika pulang < 24 jam 3. Pastikan area tangan kanan dan kaki dalam keadaan bersih dan hangat C. Langkah-Langkah 1. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan jika diperlukan 2. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir) 3. Bayi sudah berusia 24 jam 4. Pasang probe di tangan kanan 5. Pastikan bayi nyaman dan hangat, lalu nyalakan pulse oksimeter 6. Observasi nilai saturasi yang muncul di layar, pastikan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING PENYAKIT JANTUNG BAWAAN (PJB) KRITIS		
	No.Dokumen 431.1/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	dilayar terlihat gelombang yang merupakan detak jantung pasien 7. Tunggu selama 30 detik 8. Nilai saturasi yang muncul setelah 30 detik disebut preductal 9. Lepaskan probe dari tangan kanan 10. Pastikan kaki hangat sebelum dipasangkan probe 11. Pemasangan probe dapat dilakukan pada kaki kanan atau kaki kiri 12. Pasang probe di kaki kanan 13. Pastikan bayi nyaman dan hangat 14. Observasi nilai saturasi yang muncul di layar, 15. pastikan dilayar terlihat gelombang yang merupakan detak jantung pasien 16. Tunggu selama 30 detik 17. Nilai saturasi yang muncul setelah 30 detik disebut postductal 18. Lepaskan probe dari kaki, pastikan bayi nyaman dan hangat 19. Matikan alat pulse oksimeter 20. Catat kedua nilai saturasi yang didapat pada NSO Chart 21. Gunakan stempel atau formulir khusus skrining PJB untuk memudahkan monitoring mutu layanan. 22. Interpretasi Hasil (Algoritma) a. LOLOS (PASS) : 1) Saturasi $\geq 95\%$ di tangan kanan dan salah satu kaki, dengan selisih antara keduanya $\leq 3\%$ 2) Tindakan : Perawatan rutin bayi baru lahir b. ULANG (REPEAT) : 1) Saturasi 90 - 94% di tangan kanan dan salah satu kaki, atau 2) Selisih (perbedaan) saturasi antara tangan dan salah satu kaki $> 3\%$ 3) Tindakan : Ulangi pemeriksaan 1 jam kemudian (maksimal 3 kali pengulangan). Jika tetap sama pada ulangan ke-3, dinyatakan Gagal c. GAGAL (FAIL) : 1) Saturasi $< 90\%$ pada tangan kanan atau salah satu kaki. 2) Tindakan : Laporkan ke Dokter Spesialis Anak, lakukan pemeriksaan fisik lanjutan (Ekokardiografi jika diperlukan)		
Unit Terkait	1. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 2. Perinatologi 3. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4. Instalasi Rawat Inap (IRNA)		